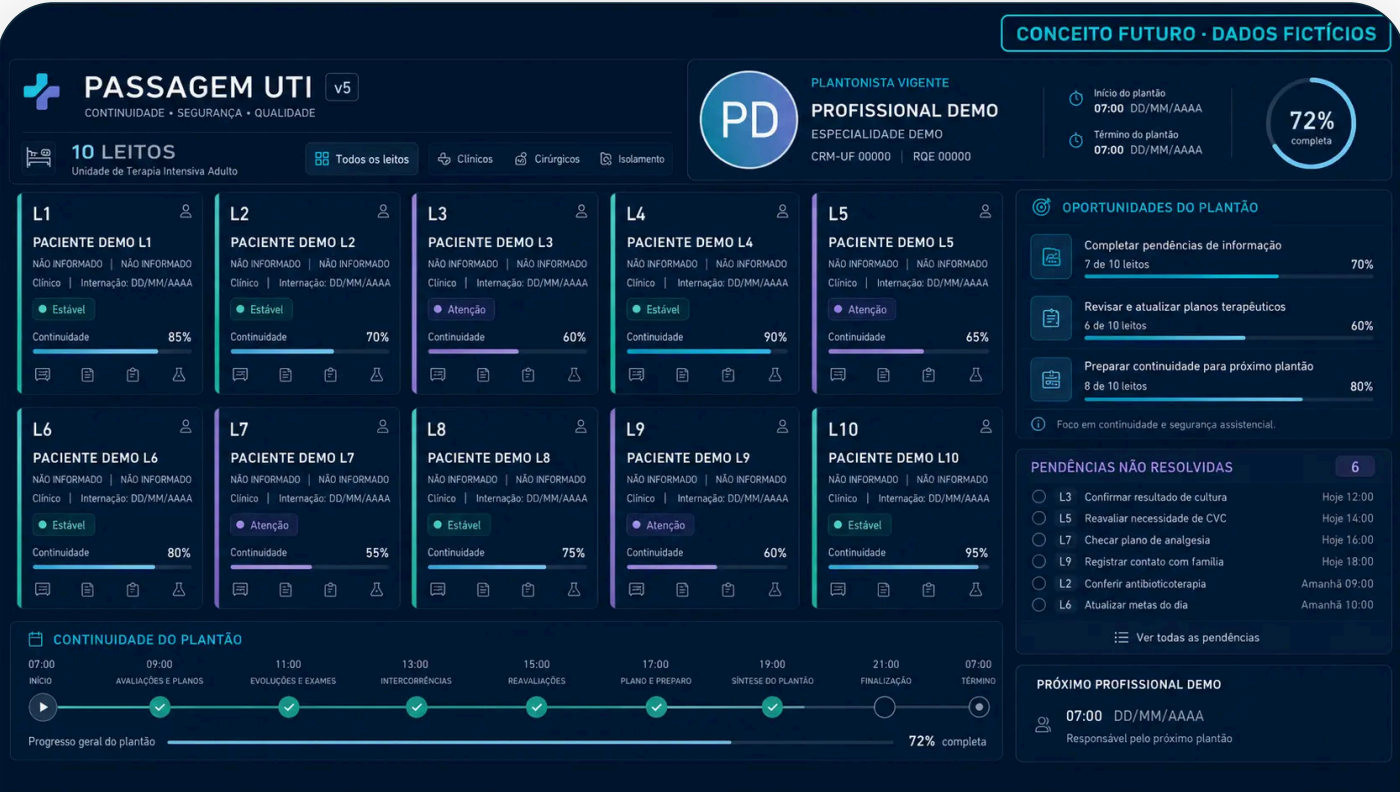


Uma foto clara do plantão. Dez leitos prontos para continuar.

Este manual leva você da instalação à entrega segura: perfil vigente, dez baterias, dez linhas, pendências, read-back, exportações e Cápsula UTI.

KEY chave fora do navegador **10** carga indica completude, não desempenho **MD** toda saída exige revisão médica



CONCEITO · visão-alvo ilustrativa com dados fictícios; não é captura da versão em execução.

O plantão inteiro em seis movimentos.

Se você só puder ler uma parte agora, siga esta sequência. Depois volte ao módulo que precisar.

01

Identifique

Preencha profissional, hospital, UTI, papel, modo e turno.

02

Assuma

Registre quem está vigente e o horário informativo de entrada.

03

Carregue

Selecione L1-L10, cole texto e escolha os arquivos necessários.

04

Resolva

Revise dez linhas, checklist, timeline, atividades e oportunidades.

05

Confirme

Faça o read-back e corrija qualquer dúvida antes da entrega.

06

Transfira

Escolha TXT, Markdown, PDF, WhatsApp ou Cápsula UTI.

MAP

Regra de ouro: o app organiza o que foi registrado. Ele não observa o paciente, não decide conduta e não substitui prontuário, alarmes ou avaliação à beira-leito.

Prepare uma vez. Inicie localmente.

O pacote não precisa de dependências de produção. Você precisa de Node.js 20 ou mais recente e de uma chave válida da API da OpenAI.

CAMINHO ESPERADO

 Seu usuário Documents

ou Documentos

 API KEY passagem-plantao-uti .env

arquivo oculto

```
~/Documents/API KEY/passagem-plantao-uti/.env
```

No Finder, pressione  +  +  para mostrar arquivos ocultos.

1

Confirme a versão

Abra o Terminal e execute:

```
node --version
```

Pronto quando aparecer v20 ou superior.

2

Crie ou revise o arquivo .env

O conteúdo tem uma única variável. Nunca exponha o valor em captura de tela:

```
OPENAI_API_KEY=cole_a_nova_chave_aqui
```

3

Entre na pasta do aplicativoDigite `cd` , arraste a pasta do app para o Terminal e pressione Enter.

4

Inicie o servidor local

```
npm start
```

Abra <http://127.0.0.1:4173>. Mantenha o Terminal aberto.



Atalho de dois cliques no Mac

Autorize uma vez e execute o inicializador:

```
chmod +x start-mac.command  
./start-mac.command
```

Para parar: volte ao Terminal e pressione

Control + **C**.



Rotacione a chave que veio no ZIP

Ela já circulou como arquivo e deve ser considerada exposta antes de piloto ou produção.

1. Acesse [OpenAI Platform · API keys](#).
2. Revogue a chave antiga.
3. Crie outra chave com o menor escopo aplicável.
4. Troque somente o valor no `.env` privado.

DUAS REALIDADES · SEM PROMESSA ENGANOSA

O que existe agora e o que ainda depende de infraestrutura.

A interface local já organiza o turno. A cápsula viva multiusuário permanece uma arquitetura futura, sujeita a segurança e governança institucional.

LOCAL AGORA

Um navegador, um espaço de trabalho

- ✓ Dados e anexos no navegador/perfil local.
- ✓ Servidor em 127.0.0.1 com chave fora da tela.
- ✓ Plantonista vigente e histórico neste dispositivo.
- ✓ Cápsula UTI exportada/importada manualmente.
- ✓ Coordenação somente sobre o estado local aberto.

ONLINE FUTURO

Serviço institucional multiusuário

- ✓ Login forte, autenticação multifator e papéis verificados.
- ✓ Organização, UTI, membros, escala e isolamento por instituição.
- ✓ Cápsula viva versionada e conflitos explícitos.
- ✓ Auditoria institucional, criptografia, backup e incidentes.
- ✓ Painel remoto autorizado para coordenação e diaristas.

Não disponível nesta RC: sincronização em tempo real, convites remotos, monitoramento online ou intervenção entre dispositivos.

PLANTONISTA VIGENTE

Registre responsabilidade, não velocidade.

O relógio informa contexto do turno. Não existe ranking, cronômetro de produtividade ou premiação por rapidez.

TEMPO INFORMATIVO

MD

PLANTONISTA VIGENTE · EXEMPLO SINTÉTICO

PROFISSIONAL DEMO

Medicina Intensiva · CRM-UF 00000 · RQE 00000

PAPEL Plantonista	MODO Ad hoc	ENTRADA 07:00
SAÍDA	TEMPO INFORMATIVO	

03h 20min

01

Preencha o cabeçalho

Nome completo, especialidade, CRM/UF, RQE, papel, modo, cidade, hospital, UTI, turno e data.

Nome e CRM são obrigatórios para assumir.

02

Escolha o papel

Plantonista, Coordenador ou **Diarista**. A escolha registra o contexto local; não concede identidade institucional.

03

Escolha o modo

UTI declarada localmente identifica a unidade informada pelo usuário, sem verificação institucional nesta RC. **Ad hoc** organiza um grupo local/extraoficial.

04

Assuma ou encerre

Assumir / transferir fecha a sessão anterior local e registra a nova. **Encerrar** preserva leitos e pendências.

Critério de conclusão

O painel superior mostra nome, credenciais, papel, modo e hora de entrada; o selo continua dizendo “Local neste dispositivo”.

10 BATERIAS • L1 A L10

Cada leito carrega informação executável.

A carga resume completude da passagem. Estado clínico, alerta e prioridade são sinais separados.

NÃO REPRESENTA GRAVIDADE

86%

L1

DEMO A

64%

L2

DEMO B

79%

L3

DEMO C

45%

L4

DEMO D

31%

L5

DEMO E

72%

58%

93%

24%

0%

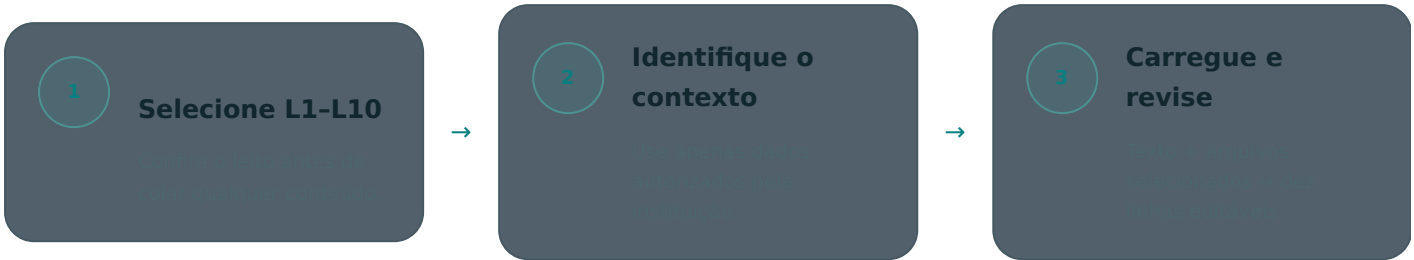
L6
DEMO F

L7
DEMO G

L8
DEMO H

L9
DEMO I

L10
VAZIO



ORDEM CLÍNICA FIXA

As dez linhas do próximo plantonista

O GPT organiza somente fatos fornecidos. Informação ausente deve permanecer como **NÃO INFORMADO** e ser revisada pelo médico.

01
Identificação e contexto

02
Diagnósticos e problemas ativos

03
Últimas 24h / intercorrências

04
Neurológico, sedação e dor

05
Respiratório e via aérea

06
Hemodinâmica, renal e metabólico

07
Infecção, antimicrobianos e culturas

08
Nutrição, dispositivos e profilaxias

09
Plano e metas do próximo plantão

10
Pendências, gatilhos e riscos

TEXTO · PDF · FOTO · DOCUMENTOS

Anexe localmente. Envie à IA somente o necessário.

O cofre pertence ao leito e ao navegador atual. Selecionar um arquivo para análise é uma ação deliberada.





Arraste ou escolha arquivos

PDF · imagem · texto · DOCX

Exemplo visual; use apenas material autorizado.

IMG

imagem_demo.png

Selecionado para análise GPT



PDF

evolucao_demo.pdf

Somente no cofre local



TXT

nota_demo.txt

Selecionado para análise GPT



8

anexos selecionados por
análise

15 MB

máximo por arquivo

22 MB

total selecionado

120 mil

caracteres de texto clínico

1

Conferir
leito



2

Selecionar
arquivos



3

Renderizar



4

Revisar 10
linhas



5

Editar antes de
usar



Falha da IA não bloqueia o plantão

Continue com edição manual. A saída da IA não prescreve, não altera automaticamente o estado clínico e não torna uma pendência obrigatória sem aceite humano.

Checklist dinâmico + linha do tempo + atividades.

Três superfícies respondem: o que falta, o que mudou e o que já foi revisado.



Checklist editável

- Texto objetivo, prioridade e prazo/gatilho.
- Conclusão manual e visível.
- Sugestão da IA permanece separada até aceite.
- Tarefa da coordenação mostra autoria local.



Linha do tempo

- Registre evento, conduta documentada, exame ou contato.
- Inclua momento e texto breve.
- O conteúdo entra no contexto da próxima renderização.
- Não substitui registro oficial no prontuário.



Atividades do leito

- Evolução concluída.
- Prescrição revisada.
- Exames revisados.
- Pendências e lacunas continuam visíveis.

EQ

Resolutividade com equidade

Essas marcas ajudam a enxergar oportunidades distribuídas entre os dez leitos. Elas não medem mérito, produtividade, tempo ideal ou qualidade individual.

Quem recebe confirma o que compreendeu.

O aceite exige nome + prontuário/ID, além da checagem estruturada do conteúdo local; idade ou data de admissão não substituem o identificador institucional. Não é assinatura digital ou homologação institucional.

EMISSOR



RECEPTOR DEMO · CRM-UF 00000

✓ Revisei as 10 linhas



RISCOS · LACUNAS ·
PENDÊNCIAS

PROFISSIONAL DEMO

10 linhas revisadas

- ✓ Conferi alertas e lacunas
- ✓ Compreendi pendências e gatilhos

Confirmar recebimento



Mudou conteúdo clínico? O aceite perde validade.

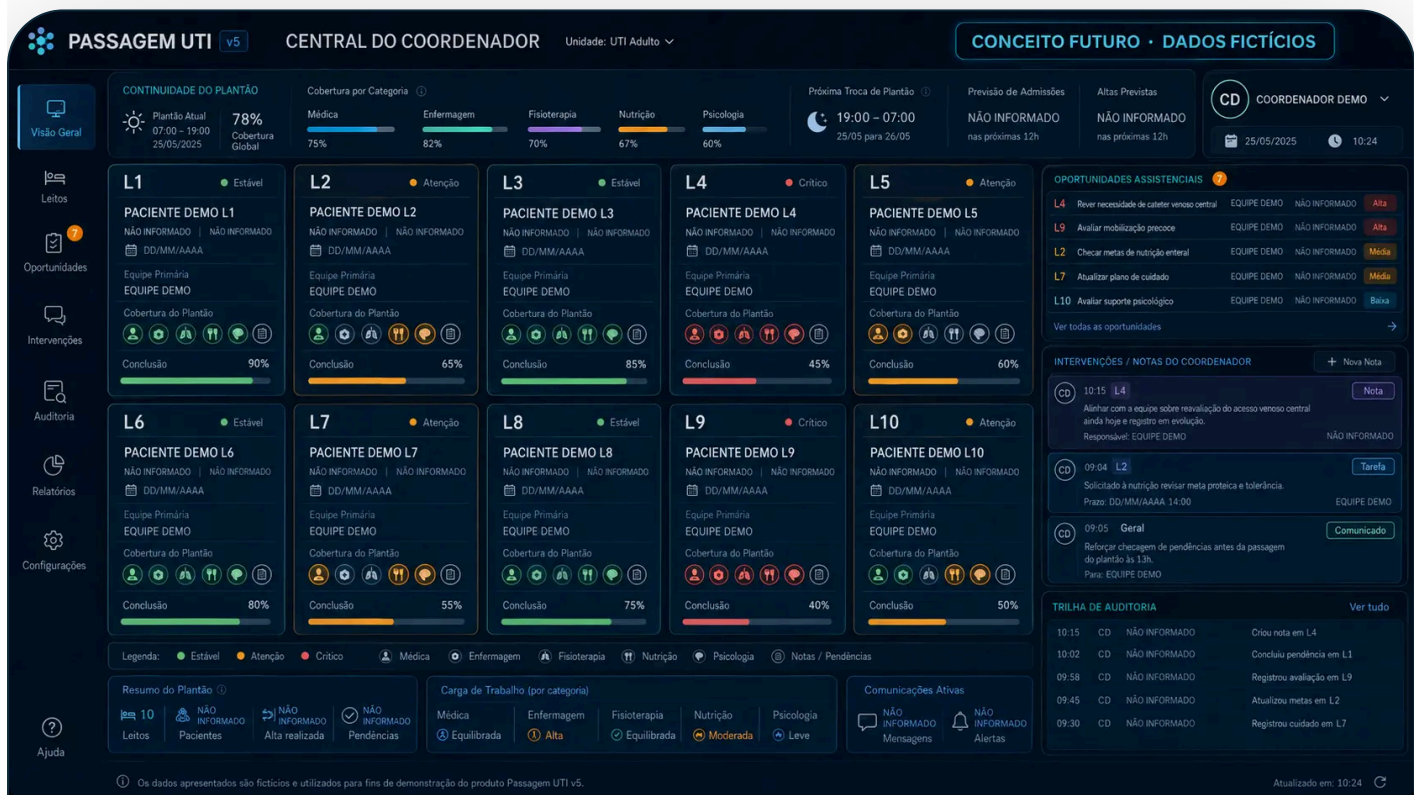
Revise novamente antes da próxima entrega. Ao importar uma Cápsula UTI, o read-back também é invalidado por segurança.

OPORTUNIDADES · EQUIDADE · SEM RANKING

Veja onde a atenção ainda pode produzir valor.

O painel usa apenas o que foi registrado neste dispositivo e mantém L1-L10 em ordem fixa.

NÃO É MONITOR CLÍNICO



CONCEITO · central online ilustrativa com dados fictícios; colaboração remota ainda não existe na versão local.

Abra “Oportunidades e histórico”

Leia completude, pendências, atividades e lacunas por leito.

Escolha a próxima oportunidade

Considere risco clínico real e contexto à beira-leito; o painel não determina prioridade.

03

Registre uma intervenção local

Assuma como

Coordenador

, escolha leito, nota ou tarefa e descreva objetivamente.

04

Confira a autoria

Nome, CRM e data entram no histórico local. Tarefas aparecem no checklist do leito.

Limite da coordenação local

Uma nota ou tarefa não prescreve nem executa conduta. Outro dispositivo não verá a mudança automaticamente. O painel remoto contínuo depende da arquitetura institucional futura.

FERRAMENTAS DE BAIXA FRICÇÃO

Central, Radar, temas, comandos e Turbo.

Use cada ferramenta como atalho operacional; nenhuma delas substitui vigilância clínica.

N

Central local

Reúne eventos registrados, alertas da IA, read-back e falhas técnicas. Não recebe sinais vitais nem envia push clínico.

📍

Radar

Resume os dez leitos pelos fatos cadastrados: estado manual, alertas, lacunas e pendências.

⌘

Ações rápidas

T3

Modo Turbo

Pressione **⌘** / **Ctrl** + **K**, pesquise leito ou ação e confirme com Enter.

Processa até três análises simultâneas, confirma custo, aceita cancelamento e descarta resposta obsoleta.



Claro, escuro ou sistema

Troque no cabeçalho. A preferência fica salva neste navegador.



Proteção de versão

Se o leito mudar durante a análise, a resposta antiga é descartada para evitar mistura de contexto.

SAÍDAS CONTROLADAS

Escolha o formato pelo destino — e revise antes de enviar.

Abra **Exportar** no cabeçalho para TXT, Markdown, WhatsApp e Cápsula. O botão de impressão do leito gera a opção PDF.

TXT

Texto simples

Leito ativo ou plantão preenchido. Útil quando o destino aceita apenas texto.

Baixa formatação; alta compatibilidade.

MD

Markdown

Estrutura títulos e listas para documentação técnica e leitura organizada.

Não envie dados clínicos para repositórios de código.

PDF

Imprimir / Salvar PDF

No leito, use o ícone de impressão. Na caixa do navegador, escolha **Salvar como PDF**.

Revise cabeçalho e conteúdo antes de salvar.

WA

WhatsApp

Prepara texto do leito ou plantão e abre o WhatsApp após confirmação explícita.

O app não escolhe contato e nunca envia sozinho.

1

Escolha leito ou plantão

2

Leia o alerta de privacidade

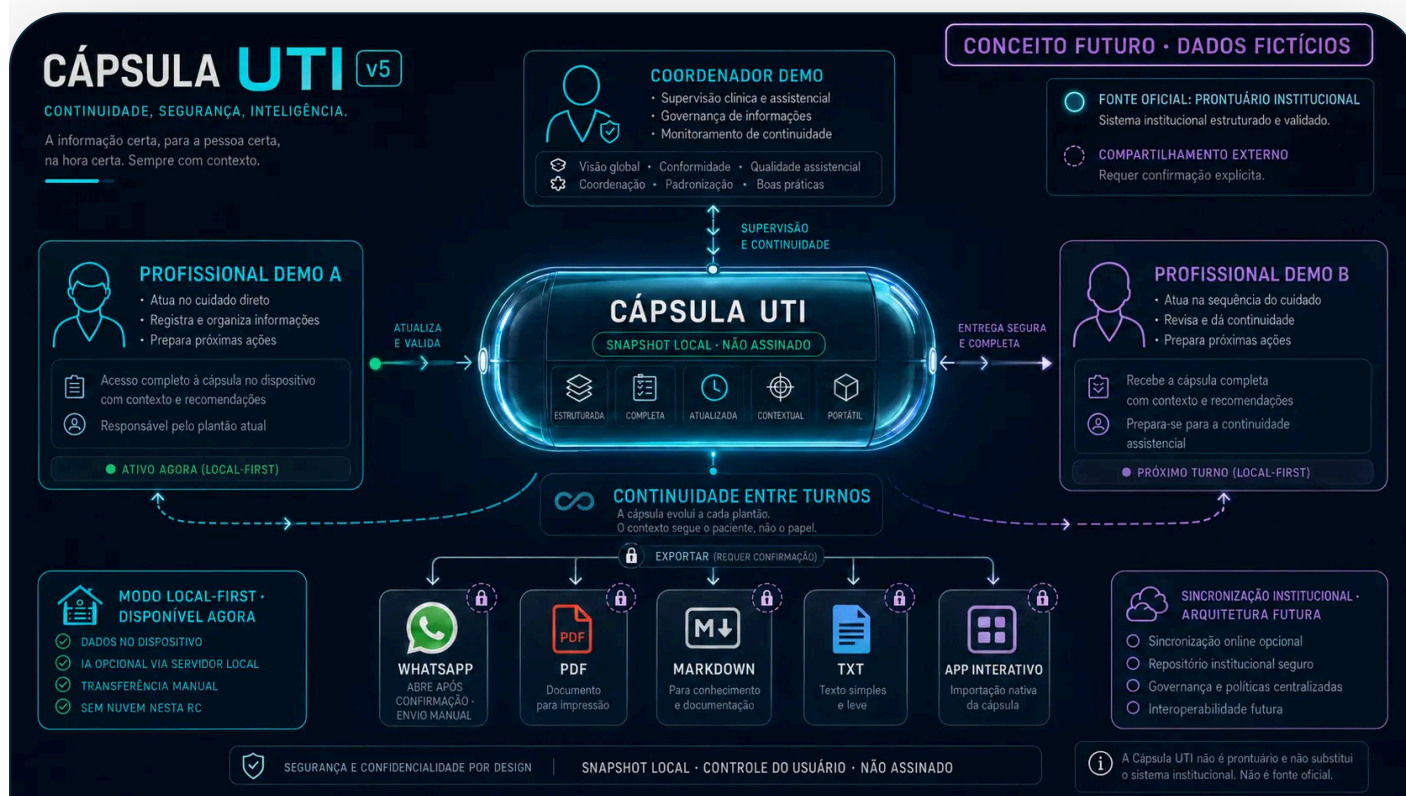
Limite: acima de 20.000 caracteres, use TXT/Markdown ou compartilhe leito por leito. Sempre siga a política institucional para comunicação de dados sensíveis.

CÁPSULA UTI · SNAPSHOT PORTÁTIL

Um arquivo que o outro app consegue validar e renderizar.

A extensão é `.capsula-uti.json`. Ela transporta o estado estruturado de um leito ou dos dez leitos — nunca uma sessão online viva.

MÁXIMO 4 MiB



CONCEITO · ecossistema futuro ilustrado com dados fictícios; na RC, a transferência exige exportar e importar manualmente.

INCLUI

- ✓ Cabeçalho aplicável e leito ativo.
- ✓ Texto clínico e dez linhas em ordem.
- ✓ Checklist, timeline, alertas e lacunas.
- ✓ Atividades e contexto necessário do snapshot.

NÃO INCLUI

- ✗ Chave da API ou arquivo `.env`.
- ✗ Fotos, PDFs, documentos ou outros anexos binários.
- ✗ Notificações locais ou cache confiável da IA.

✖ Código executável, login ou sincronização remota.

1

Exportar

Abra
Exportar → Cápsula UTI
e escolha
leito
ou
plantão

2

Transportar com canal aprovado

O arquivo pode conter dado clínico sensível. Desidentifique e proteja conforme a instituição.

3

Selecionar no outro app

Escolha o arquivo **.capsula-uti.json**. O app valida tamanho, schema, leitos, datas e tipos.

4

Escolher uma estratégia

Leia o efeito de
Mesclar
e
Substituir
antes de confirmar.

5

Reconciliar

Confirme hospital, UTI, data e paciente; revise as dez linhas e refaça o read-back.

MESCLAR

Troca somente os leitos da Cápsula

Preserva os demais leitos. Uma Cápsula de leito mantém o cabeçalho atual e bloqueia divergências de hospital, UTI ou data.

Remove os anexos locais dos leitos importados.

SUBSTITUIR

Cria o plantão a partir da Cápsula

Troca o estado local anterior, incluindo os demais leitos e o contexto aplicável.

Remove todos os anexos locais do plantão anterior.

JSON

Depois da importação: read-back fica inválido e anexos removidos não são recuperados pela Cápsula. Revise paciente/leito e reanexe somente o material correto.

Código pode ser sincronizado. Dados clínicos e chaves, não.

O aplicativo reduz exposição accidental, mas a instituição ainda precisa definir base legal, finalidade, acesso, retenção, contratos, incidentes e responsabilidades.

PODE IR PARA ESPELHOS DE PROJETO

GitHub · Notion · Drive · iCloud

- ✓ Código sem segredo.
- ✓ Documentação de produto e arquitetura.
- ✓ Prompts sem informação clínica real.
- ✓ Imagens demonstrativas com dados sintéticos.
- ✓ Pacotes de release auditados e sem `.env`.

NUNCA COLOQUE NESSES ESPELHOS

Segredos e material assistencial

- ✗ Chave, token, `.env` ou ZIP que contenha credencial.
- ✗ Nome, prontuário, exames, fotos ou documentos de paciente.
- ✗ Cápsula UTI real ou exportação clínica.
- ✗ Captura de tela identificável.
- ✗ Logs ou prompts com conteúdo clínico.

1

Navegador local

estado + anexos no IndexedDB

2

Servidor local

chave fora da interface

3

API de IA

saída exige revisão humana

!

Antes de qualquer piloto clínico

Conclua avaliação jurídica e regulatória, Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), safety case, threat model, contrato com fornecedores, testes de segurança, acessibilidade, backup/restore, resposta a incidente e aprovação institucional.

Veja o sintoma. Faça uma ação. Teste novamente.

Abra somente o item relacionado ao seu problema.

Node.js não encontrado ou versão antiga

“Permissão negada” ao abrir o inicializador

Chave não encontrada, recusada ou sem cota

Servidor indisponível em 127.0.0.1:4173

Anexos ou dados locais “sumiram”

A Cápsula foi rejeitada

A mensagem do WhatsApp ficou grande demais

Resposta da IA descartada ou nada mudou



CHECKLIST FINAL · TESTE SINTÉTICO

Pronto para demonstrar a v5 com segurança.

✓ Node 20+ e servidor local ativos

✓ Chave recebida rotacionada e fora do app

✓ Perfil, papel, modo e turno conferidos

✓ Plantonista vigente registrado

✓ Dez linhas revisadas por leito usado

✓ Arquivos selecionados de forma explícita

✓ Checklist, timeline e atividades atualizados

✓ Oportunidades usadas sem ranking

✓ Read-back concluído e válido

✓ Formato e canal de saída aprovados

✓ Cápsula reconciliada após importação

✓ Nenhum dado real em GitHub/Notion/Drive/iCloud

Salvar este manual como PDF: pressione `⌘ / Ctrl` + `P` e escolha “Salvar como PDF”. O layout de impressão foi preparado para A4.

Ferramenta de apoio à comunicação. Não substitui prontuário, prescrição, monitorização, avaliação à beira-leito, política institucional ou julgamento médico.